

I クラミジア肺炎 *Chlamydia pneumoniae*

到達目標

- クラミジア感染症の病態が説明できる
- クラミジア肺炎の疫学を説明できる
- クラミジア肺炎の臨床像を説明できる
- 適切な抗菌薬を選択できる

病因・病態・疫学

a 病因

Chlamydia とは、宿主である真核細胞（多くは哺乳動物細胞）の菌体取り込み胞（封入体）内で独特の機能的・形態的変換を通じて増殖する細胞偏性寄生性細菌である¹⁾。

b 病態

C. pneumoniae は飛沫感染によってヒトからヒトへ伝播し感染する。経気道的に *C. pneumoniae* が下気道に侵入した後、気道の粘液過分泌や過敏性亢進が病態に重要な役割を担っていると考えられ、喘息患者や慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease: COPD）の発症、急性増悪、難治化に関与する可能性がある。加えて、*C. pneumoniae* では、咳嗽が遷延することが大きな特徴のひとつであるが、これらの病態が関与していると考えられる²⁻⁴⁾。

細胞内で増殖した *C. pneumoniae* は下気道へ浸潤するか、血行性に肺野や網内系細胞など全身臓器に広がる。その後、気道や肺における免疫反応とリポ多糖や

熱ショック蛋白などによる直接障害によって組織障害を引き起こし炎症が成立すると考えられている。

c 疫学

肺炎は市中肺炎と院内肺炎に大別され、市中肺炎は病院外で日常生活していた人に発症した肺炎と定義される。この群別は、原因微生物や宿主状態が異なることに起因し、治療方針が大きく異なる。市中肺炎では *C. pneumoniae* や *Mycoplasma pneumoniae* を考慮した抗菌薬選択が必要であるが、院内肺炎や医療・介護関連肺炎では考慮する必要がない³⁾。

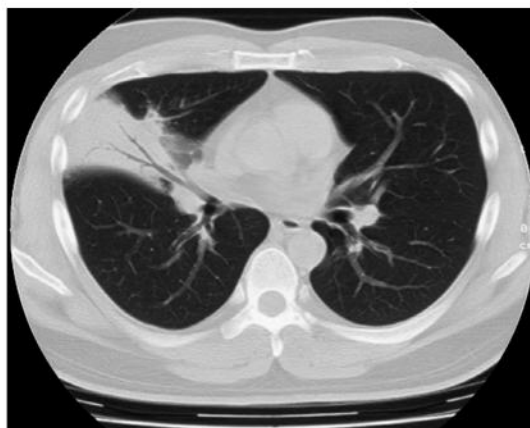
症候・身体所見

C. pneumoniae は、感染機会が多いのにもかかわらずそのほとんどが不顕性感染であり、顕性感染であっても感冒様症状にとどまることが多い。このため抗菌薬が投与されない症例が多く、小集団内でゆっくり蔓延することが大きな特徴とされている。流行事例は家族内や保育園、学校などさまざまな施設で報告されているが、軽症が多いためあまり社会的な問題とはならない。集団感染事例での呼吸器感染症の病型としては上気道炎をきたすことが最も多く、気管支炎がこれに次ぐ。

マイコプラズマ肺炎と比較した場合、クラミジア肺炎は、小児から高齢者まで全年齢層に平均的にみられること、病初期には高熱を呈することが少ないこと、などが異なる点と考えられるが症状による鑑別は難し



a.



b.

図1 肺炎クラミジアの自然治癒症例（39歳男性）

右S⁴に限局した浸潤陰影がみられ、(a)、胸部CT (b)では内部にair-bronchogramを伴っている。